七、全部小结

（一）可能可能最可能

高血脂尤其胆固醇、高血压、吸烟、糖尿病等病史，胸骨后压榨性痛、可放射至颈部/左肩/左臂、伴大汗

病例题逻辑：说了一大堆都舍不得说胸痛、为什么要先考虑冠心病呢？（但不能排除冠心病）

①阳间病例题谁最可能就选谁、不要总想着排除什么

②阴间病例题比较谁最不像

（1）心绞痛

胸痛多＜30 分钟、心肌坏死标志物正常

夜间痛	有	**ST 段抬高**→变异型心绞痛 冠脉完全闭塞,心肌全层/透壁缺血损伤	
		静息型心绞痛 ST段压低	
	无	发作频率低，程度、持续时间等**数个月内无明显变化**→稳定型心绞痛 斑块稳定"皮厚馅少"	
		发作频率高 **（1 个月来反复出现）**	恶化型：**先诊断稳定型心绞痛**
			初发型

（2）急性心梗

①多休息发作、**持续数小时**、**心肌坏死标志物↑**（红 2 钙 3 酸 4），ST 段弓背向上**抬高+病理 Q 波**（STEMI）、或 ST 段**压低≥0.1mv**（NSTEMI）　肌钙蛋白3-4小时后才会增高

患者出现胸痛2小时,肌钙蛋白阴性,心电图ST段压低≥0.1mv,没有病理Q,该患者最可能诊断?

不会优先考虑心绞痛　　非ST段抬高型心肌梗死

②急性心梗并发

乳头肌功能失调或断裂 抗缺血治疗后好转	心尖收缩期杂音（二闭）、心尖收缩中晚期喀喇音（二脱） 急性左心衰（乳头肌断裂，二尖瓣后乳头肌断裂多见于下壁心梗）
室壁瘤	超声心动图反常搏动/矛盾运动、心电图 ST 段持续抬高 持续损伤
心室游离壁破裂	急性心脏压塞、无脉性电活动
室间隔破裂	胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音
心梗后/Dressler 综合征	数周-数月出现心包炎（心包摩擦音）、胸膜炎、肺炎

（二）治疗小结

1.血运重建（PCI 和 CABG）为 **ACS 的最佳治疗** 不是稳定型心绞痛的最佳治疗(在规范药物治疗后无效才考虑血运重建),是急性冠脉综合征的最佳治疗(不稳定型心绞痛、心肌梗死)

若**心源性休克先主动脉内球囊反搏** IABP 过渡争取再灌注治疗时间（急性**右**室梗死**补充血容量**）

右室梗死的首要治疗:补液;左室梗死的首要治疗:PCI。二者根本治疗都是PCI

2.药物（注意禁忌症）　禁忌症:2234都积极笑,变异咯

	硝酸酯类（不能改善预后）	β-R 拮抗剂	CCB 长效	**抗板**	抗凝	溶栓
稳定型心绞痛	√	√	√	√	×	×
UA/NSTEMI	√	√	√	√	√	× 白色血栓
变异型心绞痛	√	×加重痉挛	√首选	√	√	×
STEMI	√	√	× 负性肌力	√	√	√ 关注禁忌症
急性右室梗死	×	√	× 负性肌力	√	√	√

禁用一切减少回心血量的药物

β-R拮抗剂对于左室梗死更有价值,因为从心律失常角度,左室梗死更容易出现恶性心律失常,而右室梗死更容易出现缓慢性心律失常和低血压休克(β-R拮抗剂禁忌症)

抗板

阿姨　　两个格格

①稳定型心绞痛：阿司匹林或吲哚布芬（抑制 COX-1），支架植入加替格瑞洛或氯吡格雷（拮抗 P_2Y_{12}/血小板 ADP 受体）

②急性冠脉综合征：**阿司匹林或吲哚布芬+替格瑞洛或氯吡格雷双联抗血小板＞1 年。PCI 术中追加替罗非班或阿昔单抗（拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体）**

真题解析·冠心病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点　心包摩擦音↑　左心功能不全↑

心悸跟体温不相称　　优先考虑急非特、病毒性心肌炎

1.2012N62 A 女性，22 岁，三天来感心悸伴胸闷，活动后明显，时有阵发性胸痛，呈针刺样，体力下降。三周前有上感发热、咽痛史，既往体健。查体：T 37.2℃，P 120 次/分，R 18 次/分，BP 100/70mmHg，平卧位，颈静脉无怒张，甲状腺I度肿大，双肺底可闻及散在湿啰音，心率 120 次/分，心律整，S_1 低钝，可闻及奔马律，P_2＞A_2，肝未及，下肢不肿。该患者最可能的诊断是　心肌炎肌钙蛋白也可↑

A.急性心包炎

B.急性心肌炎

C.急性冠脉综合症

D.甲状腺功能亢进症

2.2013N61 A 急性非 ST 段抬高心肌梗死治疗时，不宜采用溶栓疗法的主要原因是　　溶已经形成了的纤维蛋白

A.冠脉内主要是白血栓

B.冠脉阻塞不完全

C.冠脉痉挛是发病的主要原因

D.病情危急程度较轻

首选和最佳检查是心肌坏死标志物

3.2014N60 A 判断一患者是否在 1 周前左右发生急性心肌梗死，最有价值的检查是

A.超声心动图①诊断心梗的并发症

B.冠状动脉造影　确诊冠心病首选:CTA金标准DSA

C.肌钙蛋白测定　持续1-2周

D.心肌核素显像　灌注缺损显示缺血或梗死区域(瘢痕)

肺栓塞可以晕厥作为首发症状

4.2014N96-98 A 男性，75 岁。下肢骨折术后 1 周突发呼吸困难，晕厥 1 次，查体：BP 85/55mmHg，口唇发绀，颈静脉充盈，肺动脉瓣区第二心音亢进。　P2亢进→肺A高压　　高危肺栓塞

96.该患者最可能的诊断是　　如果是ST段抬高型心肌梗死要考虑溶栓禁忌症,此时不能溶栓(下肢骨折术后)

A.急性心肌梗死

B.心律失常

C.主动脉夹层

D.肺栓塞

97.对诊断该患者疾病最有价值的是

A.心电图

B.血气分析

C.CT 肺动脉造影

D.超声心动图

答案：1-4 B A C DCD

98.该患者首选的治疗是

A.起搏器置入

B.外科手术

C.介入治疗

D.溶栓治疗



5.2014N169 X 男性，50 岁。4 小时来急性胸痛，心电图诊断为“急性下壁、右心室心肌梗死”。患者胸痛持续不缓解，查体：BP 85/60mmHg，颈静脉充盈，下肢水肿(+)。以下治疗方法中，正确的有

A.适当的利尿，消除水肿

B.积极补液，适当应用多巴胺升血压 首要关键措施

C.即刻行 PCI 术血运重建 根本关键措施

D.静点硝酸甘油以缓解心绞痛

6.2015N59 A 男性，56 岁，近 1 个月来反复出现发作性胸部压抑感，自咽喉部放射，持续约 10 分钟可自行缓解，既往高血压、糖尿病病史，吸烟 35 年。为明确诊断，不宜进行的检查是

发作频率高→不稳定型心绞痛

A.24 小时动态心电图

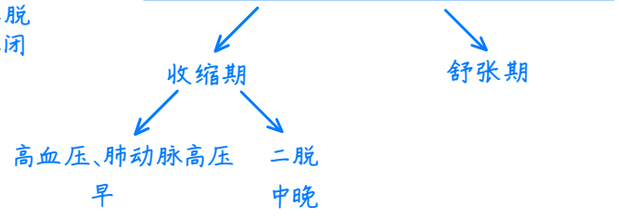
B.冠状动脉 CT

C.冠状动脉造影

D.心电图活动平板负荷试验

7.2015N91-92 A 男性，72 岁。因胸痛 24 小时，诊断急性前壁心肌梗死入院，按常规接受药物治疗。入院后第 4 天，患者再次感心前区疼痛，持续约 30 分钟，查体：心尖部内侧闻及收缩中晚期高调短促附加音伴收缩晚期杂音，与呼吸运动无关。

二脱
二闭



91.该患者新出现的附加音最可能是

A.第四心音 奔马律→舒张期额外心音

B.开瓣音 舒张期额外心音

C.喀喇音 收缩期额外心音

D.心包摩擦音

92.出现附加音最可能的病因是

A.心力衰竭

B.心室壁瘤

C.二尖瓣脱垂

D.渗出性心包炎

8.2015N169 X 急性胸痛患者，鉴别急性心肌梗死与主动脉夹层有意义的临床表现有

A.疼痛持续时间 疼痛性质✓

B.合并消化道症状

C.心肌坏死标记物

D.主动脉瓣区杂音

答案：5-8 BC D CC CD

发作频率高→UA{静息型心绞痛CCS IV级 / 变异型心绞痛}

9.2017N48 A 男性，56 岁，一个月 3 次夜间睡眠中因突发心前区疼痛而惊醒，伴出汗，咽部发紧，呼吸不畅，持续 10 分钟自行缓解，白天活动正常，既往发现血压升高 1 年，未经治疗，吸烟 20 年。查体：P 60 次/分，BP 160/80mmHg，双肺正常，心律整，心音正常，双下肢不肿，首选的降压治疗药物是

A.血管紧张素转换酶抑制剂

B.血管紧张素II受体拮抗剂

C.钙通道阻滞剂 硝苯地平

D.β 受体拮抗剂

10.2017N128-129 B

A.溶栓治疗　　根本　ACS　STEMIX禁

B.介入取栓治疗　　抗板　抗凝　溶栓

C.抗凝治疗

D.抗血小板治疗

凝血因子打转转

男性，66 岁，高血压 4 年，半年前房颤，超声心动图示左房大，宜选用的治疗方法是

男性，72 岁，1 周前急性前壁心肌梗死，PCI 治疗，左房前降支植入药物洗脱支架，宜选用的治疗方法是

憋憋出问题

11.2019N47 A 男性，58 岁。因活动后心悸、胸闷、气短半年来院，15 年前发现血压高，从未诊治，吸烟 30 年。父亲 40 岁死于心肌梗死。查体：P 82 次/分，BP 150/70mmHg，双肺(-)，心界向左下扩大，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音。超声心动图示左心房增大、左室壁增厚、二尖瓣瓣尖稍增厚，室壁运动正常。应首先考虑的诊断是

左室大　二闭

A.高血压心脏病

B.风湿性心瓣膜病 超声没有报反流

C.扩张型心肌病

D.冠状动脉性心脏病

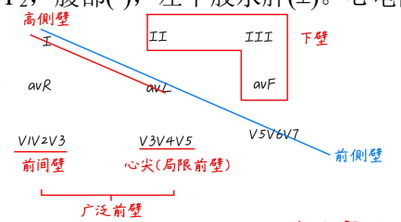
发作频率高→UA

CCS IV级与活动不受限矛盾　　步行来院:相当于自己给自己做个平板

12.2019N76-78 A 女性，49 岁，近 2 个月无诱因出现心前区气促，憋闷，持续 10 分钟至半小时不等，发作时伴乏力、四肢麻木、手心出汗，活动不受限。1 小时来症状再发并持续不缓解，步行来院。既往高血脂，无其他病史。其父患心脏病猝死。查体：P 80 次/分，R 16 次/分，BP 130/70mmHg，肥胖体型，双肺(-)，心界不大，心律整，心尖部可闻及 2/6 级收缩期杂音，$A_2=P_2$，腹部(-)，左下肢水肿(±)。心电图提示：III、aVF、V_5 导联 T 波低平。

功能性杂音

只有T波倒置无意义,必须伴有ST段改变



患者生命体征平稳且无胸痛表现

76.根据目前资料，患者最不可能的疾病是

A.心脏神经官能症 阳间病例题选A

B.急性心肌梗死

C.不稳定型心绞痛

D.肺栓塞 肥胖是肺栓塞危险因素之一、不对称下肢水肿、呼吸困难

肺栓塞:下肢深V血栓形成
突发呼吸困难
P2亢进(栓塞程度轻,对肺循环影响小,无肺A高压)
右心功能不全

77.此时给予患者最正确的处理措施是

A.对症处理，临床观察

B.保证氧供，急诊溶栓

C.积极抗凝，抗血小板

D.血运重建，急诊介入

78.患者症状缓解后 2 周再次来院，为明确诊断，此时首选的检查是

A.超声心动图 心梗并发症

答案：9-12 C CD A BAD

B.冠状动脉造影 有创,不能作为首选
C.肺通气灌注检查 肺栓塞
D.运动负荷心电图

13.2020N47 A 男性，60 岁，突发左胸持续压榨性疼痛伴大汗 3 小时。自含速效救心丸无效，急送来院。查体：P 85 次/分，BP 80/50mmHg，神清，四肢皮肤发凉，双肺未闻及啰音，心律不整，心尖部 S_1 低钝。心电图示：窦性心律，偶发房性早搏，I、aVL、V_2-V_6 导联 ST 段抬高，T 波倒置。下列急诊处理正确的是
A.积极静脉输液扩容
B.静脉注入利多卡因
C.静脉注入硝酸甘油
D.置入主动脉内球囊反搏

14.2021N46 A 男性，69 岁。因 2 小时前（凌晨 5 点）在睡眠中突发心前区疼痛伴大汗，自服速效救心丸无效，凌晨 7 点急送来院。即刻作心电图：II、III、aVF 导联 ST 段弓背向上抬高 0.2-0.4mv。采血检查，最可能异常的项目是
A.肌钙蛋白 T
B.谷草转氨酶
C.肌酸激酶同工酶 CK-MB
D.肌红蛋白

	肌红蛋白 SMB	肌钙蛋白 cTn	肌酸激酶同工酶 CK-MB
升高	最早（2 小时内）	3-4 小时后	4 小时内
恢复	最早（1-2 天）	最晚（持续 1-2 周）	3-4 天
意义	敏感性最高 （红枣）	特异性最高 最有价值	敏感性、特异性均可 ①1-2 周内诊断再发心梗 1-2周肌钙蛋白没有恢复 ②较准确反映梗死范围 ③高峰提前出现（＜14 小时）间接判断溶栓再通

脉压↑:老高闭闭闭

15.2021N48 A 女性，46 岁。因活动后心前区疼痛 2 个月，每次自含硝酸甘油无效来诊。既往有高血压、关节炎史。查体：P 80 次/分，BP 150/65mmHg，BMI 35kg/m²。甲状腺无肿大，双肺(-)，心律整，心界向左扩大，心尖部 S_1 减弱，可闻及舒张早中期隆隆样杂音，胸骨左缘第 3 肋间闻及舒张期叹气样杂音，双下肢水肿(±)。该患者心前区疼痛的最主要病因是
脉压85
相对性二狭 ← 主闭
(A-F杂音)
A.二尖瓣狭窄
B.冠心病，高血压病
C.肥厚型梗阻性心肌病
D.主动脉瓣关闭不全

稳定型心绞痛　发作频率出现变化
16.2022N76-78 A 男，65 岁。一年来快跑时感心前区闷痛，持续 3-5 分钟，休息即可缓解。近一个月来快步行走或上二层楼后即出现胸痛，疼痛较前加重，可持续 10 分钟左右，伴出汗。一天前再次发作，口含硝酸甘油可缓解，胸痛发作时可见心电图有 ST-T 改变，诊断为冠心病。
发作频率高→不稳定型心绞痛
76.该患者冠心病的分型是
A.稳定型心绞痛
B.不稳定型心绞痛
C.非 ST 段抬高型心肌梗死
D.急性 ST 段抬高型心肌梗死
77.根据加拿大心血管病学会（CCS）分级，该患者疾病严重度是　200米,一层楼
A.I 级
B.II 级
C.III 级
D.IV 级
78.该患者最佳治疗选择为

答案：13-16 D D D BBC

A.溶栓治疗
B.长效硝酸甘油口服
C.PCI 术
D.加用 β 受体拮抗剂

17.2023N46 A 男性，65 岁。4 小时前突发胸痛，持续不缓解，外院确诊为“急性下壁、右室心肌梗死”即转入院。查体：BP 82/55mmHg，神清，双肺(-)，心率 54 次/分，心律齐，心音低钝，四肢末梢皮温正常。此时应首先采取的治疗措施是
A.即刻静点硝酸甘油
B.静脉快速输液
C.静点多巴胺升血压
D.即刻置入临时起搏器

18.2024N46 A 男性，78 岁。6 小时前在睡眠中突发胸痛，有明显压迫感，自含硝酸甘油 2 片，症状稍有缓解。2 小时前胸痛再次加重，持续不缓解伴呼吸困难而来院。既往有高血压病 20 年，糖尿病 18 年。查体：R 20 次/分，BP 88/50mmHg，口唇发绀，双肺满布湿啰音，心率 106 次/分，心律齐，心音低钝，四肢末梢皮肤湿凉。心电图示 $V_{2\text{-}6}$、I、aVL 导联 ST 段水平下移 0.2-0.4mv，T 波倒置，cTnT 1.58μg/L↑。对该患者应采取的治疗措施是　非ST段抬高的心梗
A.即刻静脉补液扩容，提升血压
B.在使用升压药的同时，即刻溶栓治疗
C.即刻在置入 IABP 同时行冠脉介入治疗 为做PCI争取时间
D.即刻给予血管扩张剂及利尿剂，控制心衰

19.2024N47 A 最能反映存在急性心肌缺血的辅助检查结果是
A.冠状动脉造影显示血管狭窄＞70% 看冠脉
B.心电图出现 ST-T 动态改变 反映缺血损伤
C.超声心动图出现弥漫性室壁运动减弱 扩心病
D.监测血压出现收缩压波动超过 40mmHg

20.2025N46 A 男性，58 岁。3 天前劳累后感胸部憋闷，咽部发紧，持续数分钟缓解，无胸痛，平日活动不受限。既往有高血压病 5 年，服药控制，无糖尿病病史，吸烟 30 年，20 支/天。查体：BP 142/88mmHg，心肺(-)。静态心电图及超声心动图正常；血脂正常；冠状动脉 CT 示右冠状动脉中段 60%狭窄。为决定该患者下一步治疗方案，首选的检查是　>50%
A.运动负荷心电图 将症状与冠状动脉狭窄联系
B.动态心电图
C.动态血压
D.冠状动脉造影 有创

思维导图 • 冠心病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：17-20 B C B A